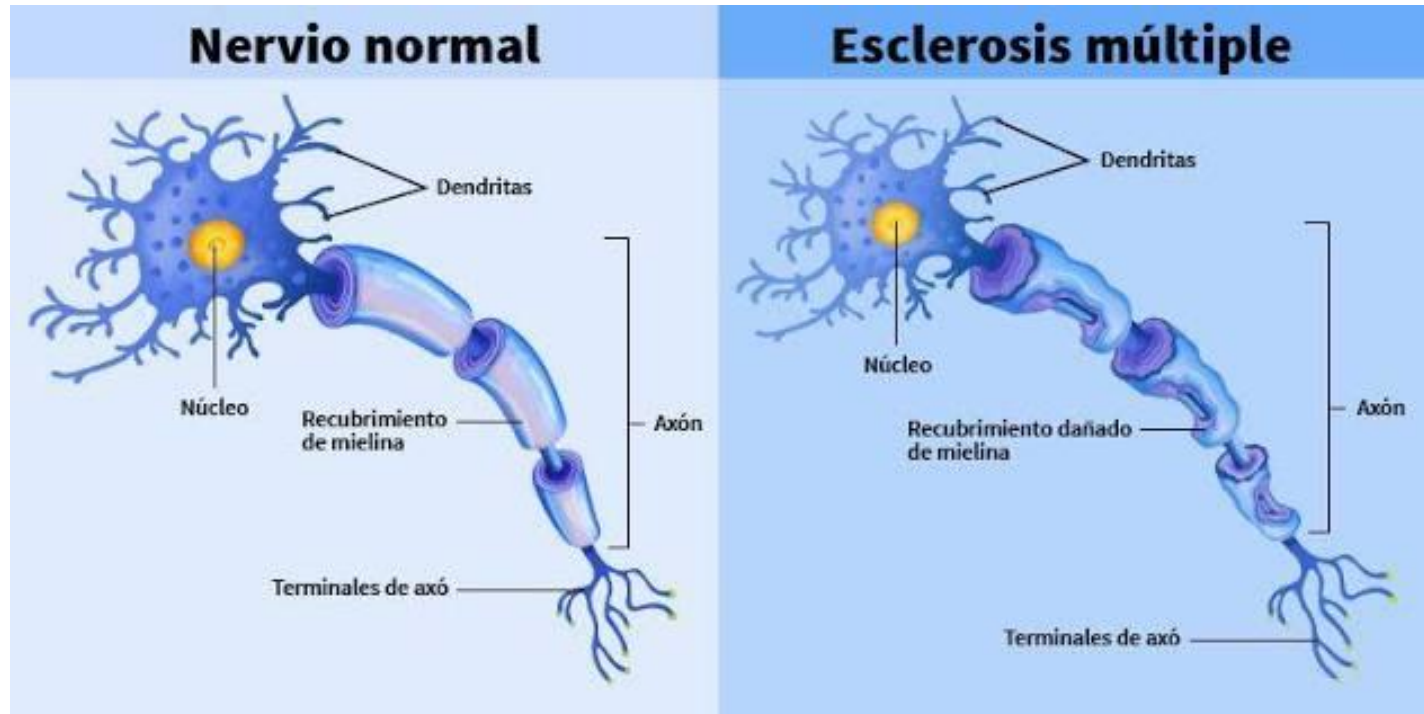


REHABILITACION NEUROLOGICA

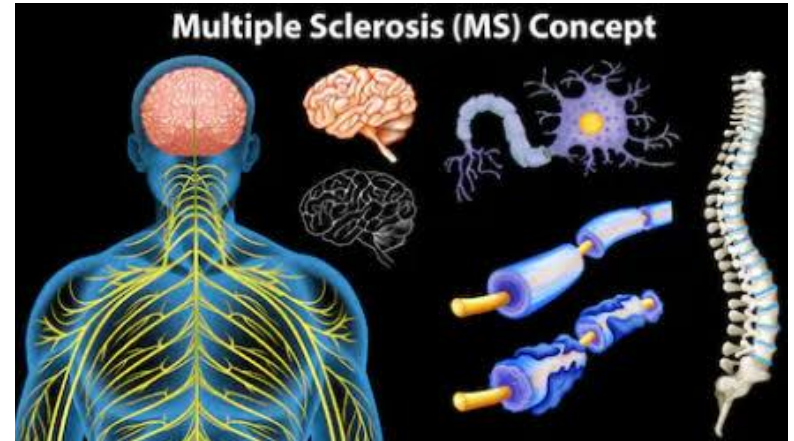
T.M. Terapia física y rehabilitación
Lic. Yasmin del Rosario Bruno Phowell

- Logro de aprendizaje:
 - “Al finalizar la sesión, el estudiante diferencia la Esclerosis Múltiple y el Síndrome de Guillain-Barré mediante el análisis de su etiología, manifestaciones clínicas y valoración fisioterapéutica.”

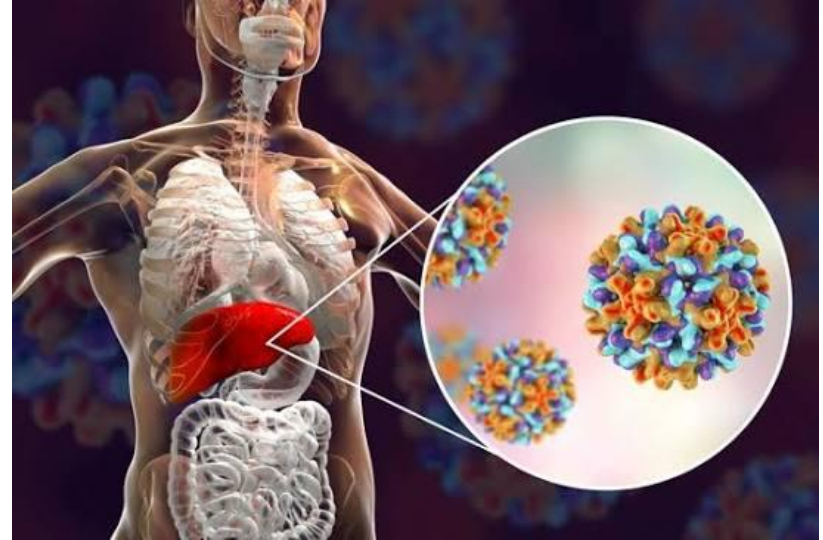
- Esclerosis múltiple



- Esclerosis múltiple (EM):
- Es una enfermedad inflamatoria.
- Es una enfermedad autoinmune.
- Es una enfermedad crónica.
- Es una enfermedad desmielinizante.



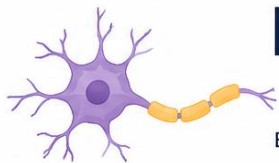
- Etiología: desconocida.
- Factores de riesgo:
 - Predisposición genética.
 - Alteraciones del sistema inmunológico.
 - Infecciones virales.
 - Déficit de vitamina D.
 - Tabaquismo.
 - Factores ambientales.



Fisiopatología:



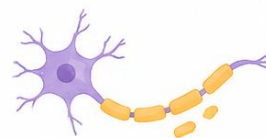
- El sistema inmunológico reconoce la mielina como cuerpo extraño.
- Produce inflamación.
- Se destruye la mielina.
- Se forman placas de desmielinización.
- La conducción nerviosa se vuelve lenta o se bloquea.



ESCLEROSIS MÚLTIPLE

MANIFESTACIONES CLÍNICAS

Enfermedad autoinmune desmielinizante del sistema nervioso central que puede afectar diferentes áreas y producir una amplia variedad de síntomas.



MANIFESTACIONES VISUALES

- Visión borrosa
- Diplopía (visión doble)
- Neuritis óptica
- Pérdida de agudeza visual
- Dolor ocular, especialmente con movimientos



MANIFESTACIONES MOTORAS

- Debilidad muscular
- Espasticidad
- Rigidez
- Fatiga
- Temblor intencional
- Dificultad para la marcha
- Pérdida de coordinación



MANIFESTACIONES CEREBELOSAS

- Ataxia (falta de coordinación)
- Desequilibrio
- Dificultad en movimientos finos y precisos



MANIFESTACIONES SENSITIVAS

- Hormigueo o parestias
- Entumecimiento
- Disminución de la sensibilidad
- Sensación de descarga eléctrica con ciertos movimientos (signo de Lhermitte)



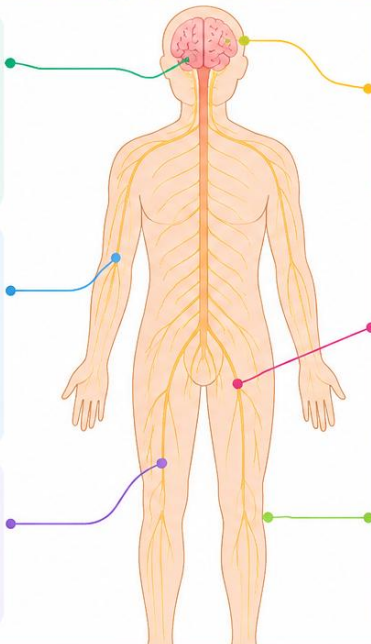
ALTERACIONES ESFINTERIANAS

- Urgencia urinaria
- Aumento de la frecuencia urinaria
- Dificultad para iniciar la micción
- Incontinencia urinaria
- Estreñimiento



OTRAS MANIFESTACIONES

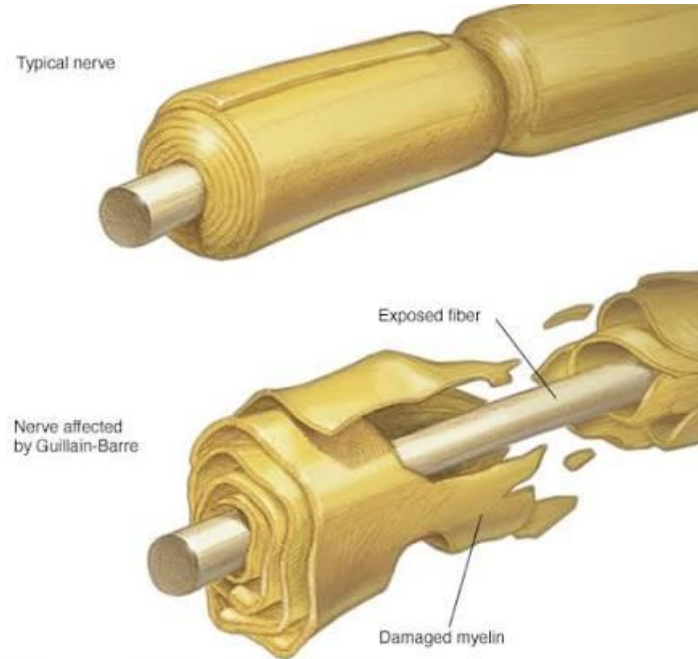
- Dificultades de memoria y atención
- Alteraciones del estado de ánimo (depresión, irritabilidad)
- Dolor
- Intolerancia al calor (fenómeno de Uhthoff)
- Trastornos del sueño



Los síntomas varían en cada persona, pueden aparecer en brotes o de forma progresiva y afectan la calidad de vida. Un diagnóstico y tratamiento oportuno mejoran el pronóstico.

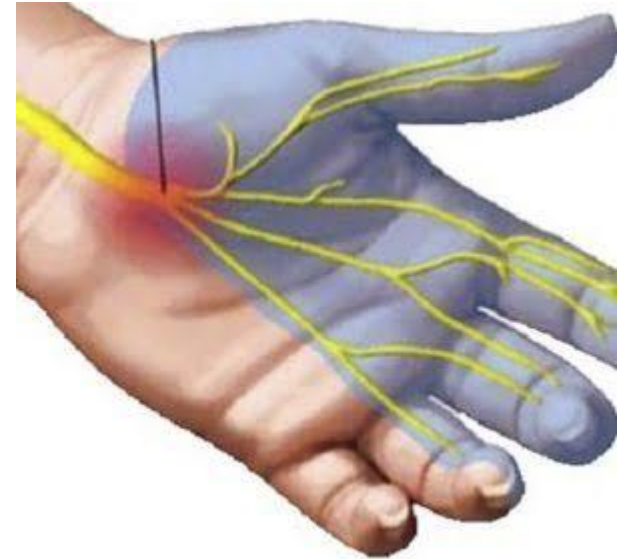


- Síndrome de Guillain – Barré (SGB)



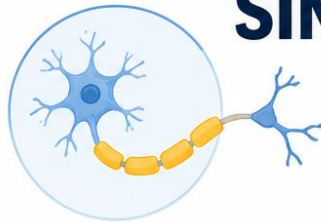
Generalidades:

- Es una polirradiculoneuropatía inflamatoria aguda de origen autoinmune.
- Afecta al sistema nervioso periférico.
- Produce debilidad muscular progresiva.
- Suele comprometer músculos respiratorios.
- Aparece después de una infección.



- Infecciones frecuentes:
- Gastroenteritis por *Campylobacter jejuni*.
- Infecciones respiratorias.
- Citomegalovirus.
- Virus de Epstein – Barr.
- Influenza
- En algunos casos después de una cirugía.





SÍNDROME DE GUILLAIN-BARRÉ

MANIFESTACIONES CLÍNICAS



Enfermedad autoinmune aguda que afecta los **nervios periféricos**. Se caracteriza por **debilidad muscular progresiva** que generalmente comienza en las piernas y **asciende** hacia el tronco y los brazos.

¿QUÉ LO CAUSA?

Generalmente aparece después de una infección (gastrointestinal o respiratoria). El sistema inmunológico ataca por error los nervios.



1. DEBILIDAD MUSCULAR

- Debilidad simétrica que inicia en las piernas y asciende hacia los brazos.
- Puede llegar a comprometer los músculos del tronco, cuello y cara.



2. ARREFLEXIA (O HIPORREFLEXIA)

- Disminución o ausencia de los reflejos osteotendinosos.
- Es un hallazgo característico.



3. ALTERACIONES SENSITIVAS

- Hormigueo, adormecimiento u "alfileres" y agujas" en manos, pies o piernas.
- Puede haber dolor muscular o radicular.



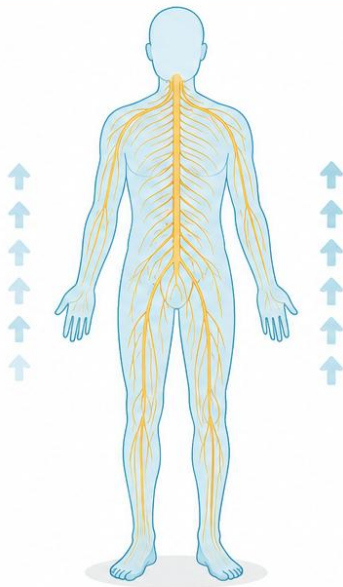
4. FATIGA

- Sensación de cansancio y debilidad generalizada que limita las actividades diarias.



ALERTA

Si aparece debilidad que progresa rápidamente, dificultad para respirar o tragar, buscar atención médica inmediata.



5. COMPROMISO DE PARES CRANEALES

- Parálisis facial (cara caída).
- Dificultad para mover los ojos.
- Problemas para hablar o tragar.



6. COMPROMISO RESPIRATORIO

- Debilidad de los músculos respiratorios.
- Disminución de la capacidad vital.
- En casos graves puede producir insuficiencia respiratoria (emergencia médica).



7. ALTERACIONES AUTONÓMICAS

- Variaciones de la presión arterial.
- Taquicardia o bradicardia.
- Sudoración excesiva o disminuida.
- Retención urinaria o estreñimiento.



8. EVOLUCIÓN CLÍNICA

- Fase aguda: los síntomas progresan durante días o semanas (máx. 4 semanas).
- Fase de estabilización: los síntomas dejan de progresar.
- Fase de recuperación: la mejoría puede ser lenta y durar meses o incluso años.



TRABAJO EN EQUIPO

El manejo integral con el equipo de salud (médico, fisioterapeuta, enfermería, entre otros) es fundamental para la recuperación.

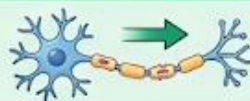


LO QUE DEBEMOS RECORDAR

El Guillain-Barré puede afectar a cualquier persona. La detección temprana y el tratamiento oportuno mejoran el pronóstico y la recuperación funcional.

TRATAMIENTO REHABILITADOR Y SU IMPORTANCIA EN SGB Y EM

SÍNDROME DE GUILLAIN-BARRÉ (SGB)



Afección Aguda y Monofásica
(Sistemas Nerviosos Periféricos)

FASES CLAVE DE REHABILITACIÓN

1. Fase Aguda: Estabilización



Ejercicios de rango
de movimiento pasivo



Apoyo
respiratorio



Light
ejercicios

2. Fase de Recuperación: Rehabilitación Intensiva



Fortalecimiento
progresivo



Reeducación
de la marcha



Terapia
ocupacional



OBJETIVOS PRINCIPALES



Restaurar
función motora



Prevenir
complicaciones



Maximizar
independencia

BENEFICIOS A LARGO PLAZO

Recuperación funcional total o parcial
Menores secuelas

IMPORTANCIA DEL TRATAMIENTO REHABILITADOR

- Enfoque Multidisciplinario Multidisciplinario
- Planes Personalizados
- Mejora de la Capacidad Funcional
- Prevención de Discapacidad y Complicaciones
- Aumento de la Calidad de Vida y Autonomía



Equipos médicos,
terapeutas y pacientes
trabajando juntos



La rehabilitación es
clave en el manejo



No es una cura, pero
mejora el pronóstico

ESCLEROSIS MÚLTIPLE (EM)



Enfermedad Crónica y Progresiva/Recurrente
(Sistemas Nerviosos Centrales)

ESTRATEGIAS DE REHABILITACIÓN

Rehabilitación Continua e Integral



Manejo de
síntomas



Terapia física
y ocupacional



Apoyo
neuropsicológico

Mantenimiento y Adaptación



Ejercicios de
resistencia



Estrategias de
ahorro de energía



Reentrenamiento
de vejiga/intestino

OBJETIVOS PRINCIPALES



Manejar brotes
y progresión



Mejorar
calidad de vida



Fomentar la
autogestión

ENFOQUE A LARGO PLAZO



Ralentizar declive funcional
Mantener participación social

- <https://youtu.be/5t0GkYYcY-8>
- <https://youtu.be/4tZEli192xg>

GRACIAS

Presente.